

🦋 甲状腺专项分析报告 (10 年随访)

吴玲 (女) · 2016-2026 · 基于 8 次体检超声 + 甲功 + 抗体数据

📅 随访年限: 10 年 🎯 当前结节: 双侧多发 (左 6×4 / 右 10×5 mm)

📊 最新分级: C-TIRADS 3 类 🩺 甲功: 历年均正常

📅 演变时间线 (2014-2026)

年份	超声所见	特征 / 分级	TSH	抗体
2014	未见异常	—	未查	—
2015	触诊 I 度肿大, 超声未见结节	单纯性甲状腺肿	1.00	—
2016	左侧 2×2mm (首现)	边界清晰	未查	—
2018	右侧 16.3×7.2mm	形态不规则、毛刺状、浸润样	未查	—
2023	左侧 3×3mm 高回声	边界清晰	2.012	正常 (TG 降低)
2024	左叶 6×4mm	C-TIRADS 3 类, 实质回声不均	2.83	正常
2025	双侧多发: 左 7×4 / 右 10×6	腺体增粗、回声欠均	2.166	TM-Ab 12.49↑
2026	双侧多发: 左 6×4 / 右 10×5	低回声、周边血流信号	3.089	正常

四个关键判断

① 结节性质：良性可能大，但需持续分级随访

2024 年明确为 **C-TIRADS 3 类**（恶性概率 <5%，良性可能大），是最有力的良性证据。

但 2026 年结节从“高回声/等回声”变为低回声且周边出现血流信号，提示近年影像特征有变化，需重新做 TI-RADS 分级确认。

② 2018 年那个 16.3mm 结节值得留意

2018 年右侧 16.3×7.2mm 形态不规则、毛刺状，描述偏警惕。但 2025-2026 年右侧又回到 10mm 左右——可能：① 哺乳期甲状腺生理性增大后的缩小；② 不同医院测量差异。

建议近期超声时请医生对比历史图像，确认是否为同一病灶。

③ TSH 缓慢上升（最需关注的信号）

TSH: 1.00 (2015) → 2.012 (2023) → 2.83 (2024) → 2.166 (2025) → 3.089 (2026)，仍在正常范围但呈缓慢上行趋势；同时 2024-2025 年出现“实质回声不均匀/腺体增粗”。

结合 2025 年 TM-Ab 一过性升高 (12.49, 参考 <10)，提示存在桥本甲状腺炎（自身免疫性甲状腺炎）早期倾向——这是 TSH 上升的最常见原因。

④ 甲状腺功能：历年均正常

T3 / T4 / FT3 / FT4 全部年份都在正常范围，**无甲亢、无甲减的化验证据**；甲状腺相关肿瘤标志物及抗体基本稳定。

✅ 建议行动（按优先级）

优先级	行动	说明
近期（1 个月内）	挂内分泌科复查三件套	甲状腺彩超（TI-RADS 分级）+ 甲功全项（含 TSH）+ 抗体（TPO-Ab / TG-Ab / TM-Ab）
复查时	请医生对比历史图像	确认 2018 年右侧 16.3mm 结节与现结节是否为同一病灶
重点	关注 TSH 趋势	若继续升高超 4.34 上限，评估亚临床甲减，可能需药物干预
频率	6-12 个月复查	分级 3 类且无增大 → 常规随访；升级 4 类或快速增大 → 考虑穿刺（FNA）
生活	饮食与情绪	正常碘盐无需回避；避免长期大量海带/紫菜；保持情绪稳定

♥️ **需要放心的部分：**① 10 年随访无恶性证据（无淋巴结转移、肿瘤标志物正常、多次分级良性）；② 甲功始终正常，目前无需用药；③ 2025 年 TM-Ab 升高在 2026 年已回落正常（5.51），免疫波动有一定自限性。

数据来源：2014-2026 年 8 次体检报告（爱康国宾 6 次 + 瑞慈健康 2 次）。本报告仅供健康管理参考，不构成医疗诊断，具体诊疗请遵医嘱。

分析生成日期：2026-08-13